

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Université de Constantine 3 SALAH BOUBNIDER
Faculté de Médecine DR. BENSMAIL de Constantine
Département de Médecine

Département de Médecine

**Service d'Epidémiologie et
de Médecine Préventive**

Module : Santé, Société et Humanité (SSH)

Cours destiné aux étudiants de première année Médecine
Année universitaire : 2024-2025

INTITULE DES COURS :

- 1. LES DETERMINANTS DE LA SANTE ET LEURS EFFETS SUR LA SANTE
DE LA POPULATION.**
- 2. ETUDES DES DIFFERENTS INDICATEURS DE SANTE (INDICATEURS
DEMOGRAPHIQUES ET DE SANTE).**
- 3. NOTIONS DE BESOIN, DE DEMANDE ET D'OFFRE DE SOINS**

**Enseignante : Dr ATOUI. N Maître de conférence « B » en Epidémiologie
Et Médecine Préventive**

- I. Introduction
- II. Définitions : santé, santé publique et déterminants
- III. Concepts de santé
- IV. Classification des déterminants de santé
- V. Typologie des déterminants de la santé
 - 1- Environnement :
 - A- Environnement physique
 1. Qualité de l'air atmosphérique
 2. Qualité de l'air intérieur
 3. Qualité de l'eau de consommation
 4. Qualité de l'eau dans le milieu naturel
 - B- Environnement social
 - 2- Biologie humaine
 - 3- Habitudes de vie : (Comportements à risque)
 - 4- Organisation des soins
- VI. Exemple de modèles élaborés par l'OMS
- VII. Les indicateurs de santé et démographiques
- VIII. Notions de besoin, de demande et d'offre de soins
- IX. Conclusion
- X. Références bibliographiques

Les objectifs pédagogiques du cours :

1. Connaître la définition des concepts
2. Connaître les différents types de déterminants influant sur l'état de santé
3. Connaître les outils de mesure (indicateurs)
4. Connaître la place de l'économie dans la santé

I. Introduction

Durant le cycle de la vie, l'état de santé se caractérise par des interactions complexes entre plusieurs facteurs d'ordre socio-économique, en communs avec l'environnement physique et le comportement individuel.

Ces facteurs sont désignés comme les « déterminants de la santé ». Ils n'agissent pas isolément, c'est la combinaison de leurs effets qui influe sur l'état de santé.

II. Définitions :

1. Définition de la santé :

- **Selon R. Leriche (1936) :** « La santé c'est la vie dans le silence des organes »
- **l'OMS (1946) :** « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. ».
- **Définition de l'UNICEF (1984) :** « La santé c'est la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut d'une part réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et d'autre part évoluer avec le milieu ou s'adapter à celui-ci >>>
- **Définition Charte d'Ottawa (1986) :** « La santé n'est pas l'absence de maladie, c'est un sentiment plus profond que le bien être qui ne dépend pas seulement des services de santé mais du travail du revenu de l'éducation de la culture des droit et des libertés...»

2. Définition de la santé publique :

La santé publique est une discipline à part entière, son but est la santé de la population, et non celle de l'individu. Elle s'intéresse donc à la dimension collective, et intègre le concept de santé à la société,

C'est « l'étude, d'une part, des déterminants physiques, psychosociaux et socioculturels de la santé de la population et d'autre part des actions en vue d'améliorer la santé de la population ».

Ou encore, comme « activité organisée de la société visant à promouvoir, à protéger, à améliorer et, le cas échéant, à rétablir la santé de personnes, de groupes ou de la population entière ».

La santé publique est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et de promouvoir la santé et l'efficacité physiques à travers les efforts coordonnés de la communauté pour l'assainissement de l'environnement, le contrôle des infections dans la population, l'éducation de l'individu aux principes de l'hygiène personnelle, l'organisation des services médicaux et infirmiers pour le diagnostic précoce et le traitement préventif des pathologies, le développement des dispositifs sociaux qui assureront à chacun un niveau de vie adéquat pour le maintien de la santé, l'objet final étant de permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la longévité. »

3. Définition de déterminants de santé :

La notion de déterminant de la santé est une notion du champ de la santé publique : l'OMS en propose une définition concise dans sa formulation, mais extrêmement large dans ce qu'elle englobe : « Facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui déterminent l'état de santé des individus ou des populations ». (Organisation mondiale de santé, 1999). Ils peuvent être d'origine individuels ou collectifs ; innés ou acquis ; relevant de soins ou sans relation avec les soins. Douze déterminants ont été retenus par l'agence de santé publique du Canada

III. Concepts de santé :

- Déterminants de santé (Santé Publique) : Caractéristiques individuelles ou collectives susceptibles d'influer directement ou indirectement sur l'état de santé
- Facteur de risque (Epidémiologie) : Caractéristique associée de manière statistiquement significative à un événement de santé.

➤ DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ :

- ❖ La notion de déterminant de la santé est une notion du champ de la santé publique : l'OMS en propose une définition concise dans sa formulation, mais extrêmement large dans ce qu'elle englobe : « **Facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui déterminent l'état de santé des individus ou des populations** ». (OMS, 1999).
- ❖ Ils peuvent être d'origine individuels ou collectifs ; innés ou acquis ; relevant de soins ou sans relation avec les soins.
- ❖ **Douze déterminants ont été retenus par l'agence de santé publique du Canada :**
 1. le niveau de revenu et le statut social ;
 2. les réseaux de soutien social ;
 3. l'éducation et l'alphabétisme ;
 4. l'emploi et les conditions de travail ;
 5. les environnements sociaux ;
 6. les environnements physiques ;
 7. les habitudes de santé et la capacité d'adaptation personnelles ;
 8. le développement de la petite enfance ;
 9. le patrimoine biologique et génétique ;
 10. les services de santé ;
 11. le genre humain ;
 12. la culture.

IV. Typologie des déterminants de la santé :

Il existe une grande variété dans la typologie des déterminants de santé en rapport avec l'environnement ; la biologie humaine ; les habitudes de vie et organisation des soins.

IV.1. Les déterminants environnementaux de la santé

Facteurs extérieurs à la personne, essentiellement collectifs et acquis sur lesquels la Personne n'exerce qu'un contrôle réduit à titre individuel.

1.1 Environnement physique

- 1.1.1. Qualité de l'air :
- **Polluants atmosphériques proviennent :**
 - Trafic routier
 - Chauffage domestique
 - Activités industrielles
 - Pratiques agricoles
 - Sources naturelles (éruptions volcaniques)

1.1.2 Qualité de l'air intérieur :

Un individu passe, en moyenne 80% de son temps dans des locaux d'habitation ou de travail

- La pollution de l'air intérieur provient :
 - Entrée de l'air extérieur
 - Emission de polluants à l'intérieur des locaux :
 - Dispositifs de chauffage
 - Produits ménagers, détergents, solvants, peintures
 - Contaminants biologiques (acariens)
 - Deux Gaz toxiques identifiés et surveillés :
 - Monoxyde de carbone (cause de mortalité par inhalation)
 - Radon (L'OMS estime qu'il est la cause de 3 à 14 % des cancers du poumon)

1.1.2. Environnement/qualité de l'eau concerne :

- Qualité de l'eau de consommation dont la surveillance est le volet le plus important ; elle est physico-chimique (pesticides, nitrates) et microbiologique (bactéries traceuses). Elle permet d'éviter les épidémies d'origine hydrique.
- La qualité de l'eau dans le milieu naturel (nappes phréatiques, cours d'eau etc.) qui se dégrade de façon continue et nécessite des mesures de protection : protection des captages et limitation des rejets polluants.

2. Environnement social

Le gradient social de santé peut être en rapport avec :

- Les conditions de travail (risques professionnels, pénibilité, vécu du travail (stress, autonomie décisionnelle), instabilité des parcours professionnels, horaires etc.).
- Les habitudes de vie (recours à la prévention, aux soins), comportements (tabac, alcool, alimentation, conduite automobile...), lien entre état de santé et catégorie sociale, conditions de vie pendant l'enfance (effets à long terme des conditions de vie de l'enfance, comportements hérités).

IV.2. Déterminants biologiques

Facteurs essentiellement individuels et innés, la personne n'exerce qu'un contrôle réduit, patrimoine génétique individuel exemples : diabète insulino-dépendant, cancers, pathologies psychiatriques

IV.3. Déterminants liés aux habitudes de vie

Décisions prises délibérément par l'individu mais très dépendante de l'environnement social qui ont des répercussions sur leur santé (ou celle de leurs proches). Facteurs individuels et acquis sur lesquels l'action n'est possible que par la volonté de l'individu.

Comportements à risque : consommation de tabac, alcool, drogues illicites, violence, prises de risques sexuels, une alimentation non saine etc.

Le contrôle des facteurs de risque requière la participation active des sujets, exercice physique, nutrition, prévention (vaccination, dépistage).

IV.4. Déterminants : Organisation des soins

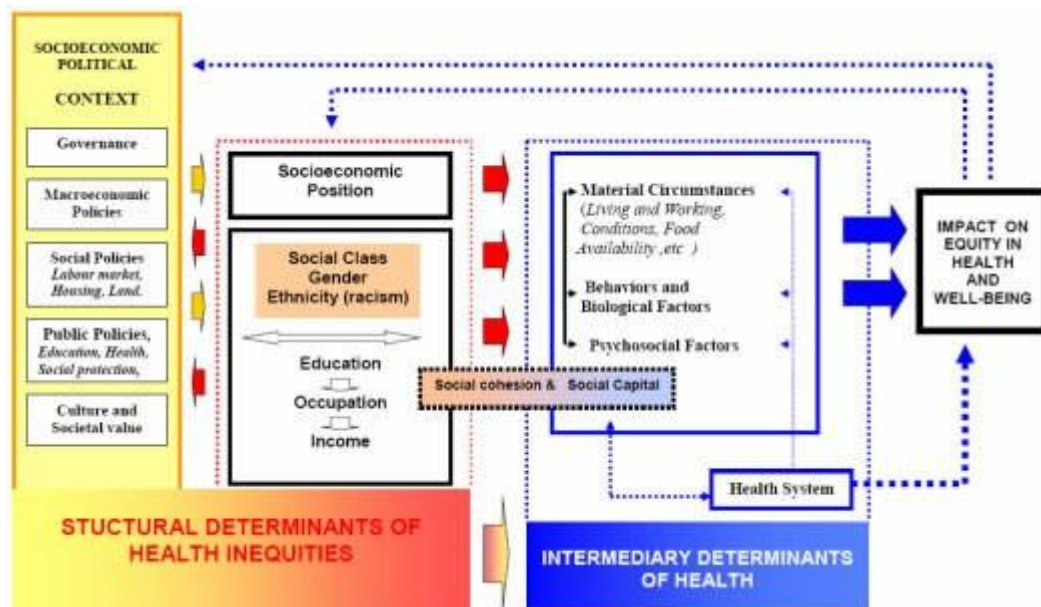
Dépend de l'offre de soins : en quantité (démographie des professions de santé, établissements, lits, places, équipements lourds). En qualité (soins primaires (1er recours) ; soins tertiaires (hautement spécialisés) avec accessibilité physique, économique, sociale et efficacité sur le plan clinique, le plan fonctionnel et sur le plan de la qualité de vie.

V. Exemple de modèles élaborés par l'OMS

L'état de santé d'une personne se caractérise donc par des interactions complexes entre plusieurs facteurs individuels, socio-environnementaux et économiques. Il existe divers

modèles explicatifs de ces déterminants de la santé, certains privilégient le rôle des conditions de naissance et de vie dans la petite enfance. D'autres se fondent sur l'effet cumulatif de déterminants sociaux et économiques défavorables se combinant et interagissant au cours de la vie s'enchainent, voire se modifient au cours du temps avec un impact différencié suivant les individus, les pays, le lieu de vie, le système socio- économique, etc. Ces courants ne sont pas exclusifs les uns des autres et peuvent être complémentaires. Ils sont présentés dans un document élaboré en 2005 pour les travaux de la commission des déterminants sociaux de la santé sous l'égide de l'OMS en mars 2005 (2005-2008). Nous citerons à titre d'exemple : Le modèle de la CSDH/CDSS ¹qui rassemble l'ensemble des déterminants reconnus. Il est fondé sur les interactions que des déterminants dits « structurels » des inégalités sociales de santé entretiennent avec des déterminants dits « intermédiaires » de l'état de santé.

1. Les déterminants structurels de l'état de santé relèvent du contexte politique et socio-



économique du pays. Parmi les facteurs qui influent sur la stratification sociale et économique du pays (et donc sur la répartition sociale de la population en fonction du revenu, de l'éducation, de la profession, du genre, de ses origines ethniques), on trouve : la gouvernance, les politiques macro-économiques, les politiques sociales, les politiques publiques, la culture et les valeurs de la société. Ces facteurs ont un impact sur la distribution inégale des déterminants intermédiaires.

¹ Modèle de la CSDH/CDSS de l'OMS (CSDH : Commission on Social Determinants of Health ; CDSS : Commission des déterminants sociaux de la santé. OMS : Organisation mondiale de la santé).

2. Les déterminants intermédiaires de l'état de santé se rapportent aux conditions matérielles, psychologiques, aux facteurs biologiques et génétiques, aux comportements, ainsi qu'au rôle de l'accès au système de santé. Parmi les éléments pris en compte, on citera pour les conditions matérielles : le logement, la qualité du quartier, la consommation potentielle (c'est-à-dire les moyens financiers d'acheter des aliments sains, des vêtements chauds, etc.), l'environnement physique du travail. Les facteurs psychosociaux renvoient au stress des conditions de vie et de travail, aux relations et au soutien social. Les comportements concernent la nutrition, l'activité physique, la consommation de tabac et d'alcool, qui ont une répartition socialement stratifiée entre les différents groupes sociaux. Il a été montré que les comportements individuels défavorables à la santé (consommation de tabac, d'alcool, mauvaise alimentation, sédentarité, etc.) dont on sait qu'ils exposent à des facteurs de risque responsables de pathologies connues pour être les premières causes de décès dans de nombreux pays (cancers, maladies cardiovasculaires, etc.) ne sont pas prépondérants pour expliquer les inégalités de santé observées et ne peuvent à eux seuls les expliquer.

NB : En fait, on s'intéresse de plus en plus au rôle médiateur que joue le système nerveux vers les autres systèmes biologiques : endocrinien, immunitaire, sanguin, etc. Par ailleurs, les stress les plus nocifs pour la santé ne seraient pas ceux découlant d'une crise, mais plutôt ceux qui durent longtemps. Des études ont permis de constater que plus on est situé au sommet de la hiérarchie sociale, plus on arrive facilement à diminuer le niveau de glucocorticoïdes après un stress aigu.

VII Les indicateurs de santé :

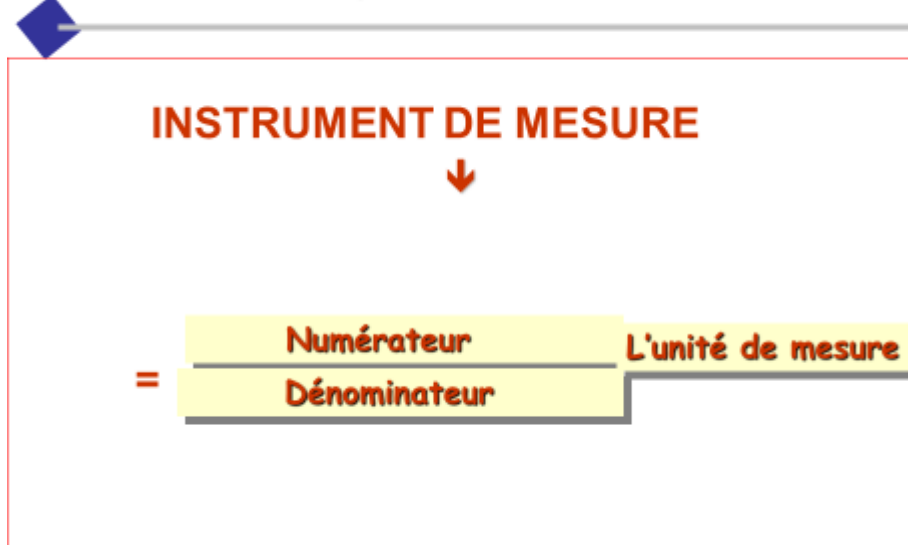
Pourquoi des indicateurs ?

Objectifs

- ◆ Connaître l'état de santé
- ◆ Définir les besoins en santé
- ◆ Déterminer les priorités en santé publique
- ◆ Évaluer le système de santé
- ◆ Définir une politique de santé :(orienté une action sanitaire)
- ◆ Mesurer les résultats des interventions d'un programme de santé.

Il convient de connaître les indicateurs de santé, leurs valeurs types, leur utilisation

2. Qu'est-ce qu'un indicateur ?



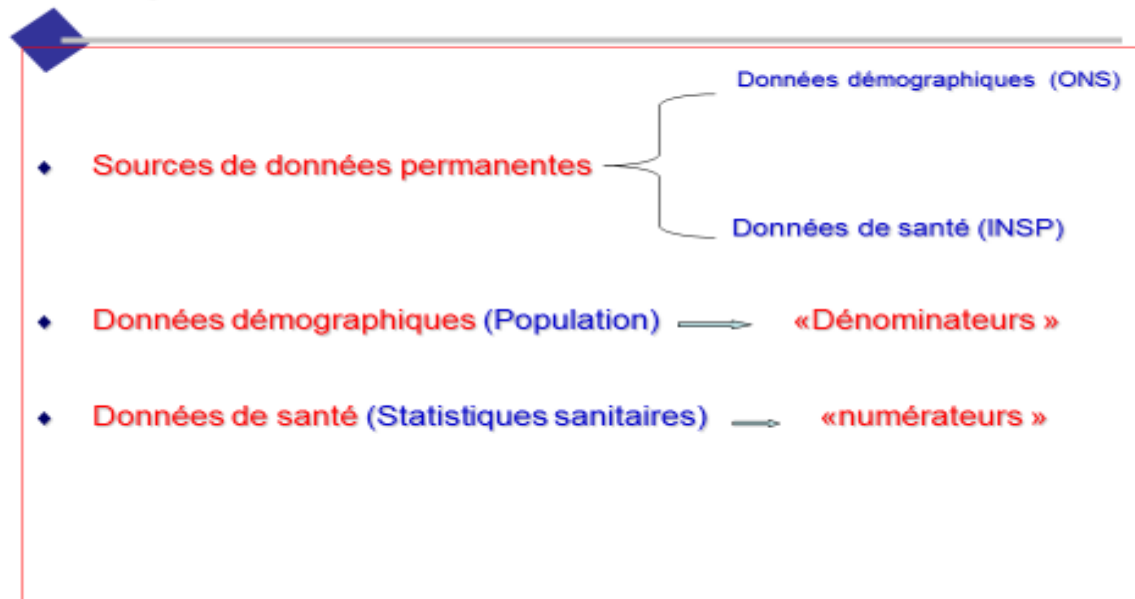
3 . Définition

◆ Descripteurs de :

- l'activité,
 - l'état
- } d'un système de santé

- ◆ Ce sont des **variables** reflétant diverses composantes de l'état de santé.
- ◆ Établies par l'épidémiologie descriptive, qui réunit les **données** nécessaires à partir des **sources d'informations**.

8. Quelles sont les sources d'information ?



I. Indicateurs de l'État santé

- ◆ Il y a deux grands types d'indicateurs
 - Indicateurs épidémiologiques de Morbidité.
 - Indicateurs épidémiologiques de Mortalité .

I.1 Indicateurs de morbidité : Prévalence

(1)

- ♦ Etude **descriptive** permettant de calculer la **prévalence** d'une maladie, d'un facteur de risque ... dans une **population donnée** pendant un temps **déterminé**
- ♦ Le taux de prévalence est donné par :

$$\text{Prévalence} = \frac{(\text{Nombre total de cas d'une affection donnée à l'instant } t)}{[\text{Nombre de personnes à risque à l'instant } t]}$$

I.2 Indicateurs de morbidité : Incidence

(1)

- ♦ C'est un taux qui prend en compte la **vitesse de survenue** de la **maladie** dans une population
- ♦ Elle s'exprime sous forme d'un chiffre compris entre 0-1 (ou pourcentage) : x cas pour cent (ou pour 1000, 10000)

1. L'**incidence cumulée**: (incidences cumulées annuelles, mensuelles, journalières)

$$\text{Incidence} = \frac{(\text{Nombre nouveaux de cas d'une affection pendant une période } \Delta t)}{[\text{Nombre de personnes à risque pendant la période } \Delta t]} \times 105$$

I. 2 Indicateurs de mortalité

- ◆ Mortalité globale
- ◆ Taux brut de mortalité
- ◆ Mortalité spécifique
- ◆ Mortalité proportionnelle
- ◆ Létalité

II. Indicateurs classiques démographiques

1. **Taux brut de natalité** =
$$\frac{\text{nombre annuel de naissances viables} \times 1000}{\text{Population au 1/2 de l'année}}$$
2. **Taux globale de fécondité** =
$$\frac{\text{Nombre annuel de (filles et garçon)} \times 1000}{\text{Nombre de femmes de 15-49ans au } \frac{1}{2} \text{ année}}$$
3. **Taux brut de reproduction** = Moyen de filles vivantes
4. **Espérance de vie à la naissance**
5. **Pyramide des Ages**
6. **Ratio de dépendance**

VIII. Notions de besoin, de demande et d'offre de soins

Le rôle de la société est de répondre aux besoins des individus dont elle a la charge, à travers différents dispositifs comme :

La justice pour les besoins de sécurité, les mesures sociales pour les personnes démunies, le système de soins ou les structures d'accueil pour couvrir les besoins de santé.

a) La notion de besoin de santé

Pour conserver sa santé, c'est-à-dire un équilibre physique, mental et social, l'homme doit satisfaire :

- des besoins primaires, indispensables au maintien de la vie biologique, au bien-être physique (manger, respirer, boire...)
- des besoins secondaires, qui varient selon les individus ou les groupes sociaux (besoins psychologiques, affectifs, intellectuels, qui correspondent au bien-être mental et social).

Les besoins correspondent donc au désir propre de chaque individu de trouver les moyens destinés à pallier les manques et les sources d'insatisfaction dont il souffre.

En économie de la santé, le besoin de santé peut ainsi être défini comme un manque, un écart entre l'état de santé existant et observé d'une part, et l'état de santé désiré d'autre part.

Les besoins de santé évoluent sans cesse avec l'amélioration de la qualité de vie et le développement du progrès médical.

- La société se crée également de nouveaux besoins (lutte contre les épidémies).
L'économie répond aux besoins de la santé par la production de biens (médicaments) et de services (consultations) proposés par les établissements de soins et les médecins.

b) La demande de santé

La demande de santé est constituée des besoins de santé exprimés et mesurés par l'économie de la santé, et qui se traduisent par le recours aux soins.

Le besoin de santé, ressenti ou réel, n'est pas toujours exprimé.

Les freins à l'expression des besoins et le renoncement aux soins sont dus :

- à l'insuffisance des remboursements et des moyens financiers,
- au manque d'information,
- au temps d'attente pour obtenir un rendez-vous.

Plusieurs causes influent sur la demande de santé, telles que:

- l'âge (après 80 ans, la consommation médicale est multipliée par trois),
- la catégorie socioprofessionnelle,
- les revenus,
- le niveau d'instruction,
- la couverture sociale
- et l'état de santé réel et désiré.

c) L'offre de santé

Permet de répondre à la demande de santé, aux besoins exprimés.

C'est le rôle du système de santé de proposer à la population les moyens pour maintenir sa santé, à travers :

- les professionnels de santé,**
- le niveau d'équipement médical à l'hôpital ou en médecine de ville,**
- le financement des soins et leur remboursement,**
- les priorités de santé publique,**
- la prévention.**

Une offre de santé est constituée par un ensemble de biens -- (médicaments, prothèses) --et de services (consultations, analyses) médicaux.

L'offre de santé évolue en quantité et qualité (réformes).

La situation idéale pour un système de santé efficient serait celle où les besoins, la demande et l'offre de santé coïncideraient exactement.

IX Conclusion

Dans la conscience collective, s'affirme à l'heure actuelle, une exigence de protection sanitaire et sociale. On prend donc en considération la prévention sociale et non plus seulement la prophylaxie et le traitement de la maladie individuellement.

Références bibliographiques

1. Jolivet A. Médecine KB ; Santé Publique, 2ème édition : Vernazobres Greco, 2011.
2. Tavalacci MP, Ladner J. Santé Publique, 2ème édition : ELSEVIER / MASSON: Cahiers des ECN , 2009 .
3. De Koninck M., Pampalon R., Paquet G., Clément M., Hamelin A.M., Disant M.J., et al. Santé : pourquoi ne sommes-nous pas égaux ? Comment les inégalités sociales de santé se créent et se perpétuent (pdf, 2,5 Mo). Québec : Institut national de santé publique du Québec, 2008 : 95 p.
4. OMS. Déterminants sociaux de la santé.[en ligne] Disponible sur : https://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/fr/
5. INPES.Qu'est-ce qui détermine notre état de santé ? santé publique France, [en ligne], disponible sur : <http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/ISS/determinants-sante.asp>